PERÚ | Ministerio de Salud

CONSIDERACIONES PARA LA **PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LAS MALOCLUSIONES EN NIÑAS Y NIÑOS**

RM N°641 - 2026/MINSA



Catalogación hecha por la Biblioteca del Ministerio de Salud

Consideraciones para la prevención y diagnóstico temprano de las maloclusiones en niñas y niños, aprobada con Resolución Ministerial N° 641-2026/MINSA / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Salud Bucal - Lima: Ministerio de Salud; 2026.
33 p. ilus.

MALOCLUSIÓN / SALUD BUCAL / SALUD INFANTIL / BRUXISMO / SALUD PÚBLICA / DIAGNÓSTICO

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2026-08626

Consideraciones para la Prevención y Diagnóstico Temprano de las Maloclusiones en Niñas y Niños
Aprobada con RM N° 641-2026/MINSA.

Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Salud Bucal. (MINSA / DGIESP / DSABU)

Responsables de la elaboración:
Dra. Raquel Jazmin Molfino Jara, Directora ejecutiva. MINSA / DGIESP / DSABU.
Dr. Robert Christian Andamayo Flores, Especialista en Salud Pública I. MINSA / DGIESP / DSABU.
Dra. Lesly Viviana Tuesta Orbe, Especialista en Salud Pública I. MINSA / DGIESP / DSABU.
Dr. Orlando Farfán Menacho, Especialista. MINSA / DGIESP / DSABU.
Dra. Carla Sofía Sanguineti Ramírez, Especialista en Salud Pública I. MINSA / DGIESP / DSABU.
Dr. Javier Lamas Lara, Consultor.

Revisora:
Dra. Raquel Jazmin Molfino Jara, Directora ejecutiva. MINSA / DGIESP / DSABU.

© MINSA, julio 2026

Ministerio de Salud
Av. Salaverry N° 801, Lima 11-Perú
Telf.: (51-1) 315-6600
https://www.gob.pe/minsa/
webmaster@minsa.gob.pe

1ª. edición, julio 2026

Versión digital disponible:
https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/7992.pdf



JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO
Ministro de Salud

HENRY ALFONSO REBAZA IPARRAGUIRRE
Viceministro de Salud Pública

LUIS MELCHOR LORO CHERO
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

JULIO CÉSAR NIÑO BAZALAR
Secretario General

CONSTANTINO SEVERO VILA CÓRDOVA
Director General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

RAQUEL JAZMIN MOLFINO JARA
Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Salud Bucal

PARTICIPANTES / COLABORADORES:

Equipo Técnico de la Dirección de Salud Bucal:

- C.D. Raquel Jazmin Molfino Jara, Directora ejecutiva
- C.D. Lesly Viviana Tuesta Orbe, Equipo Técnico
- C.D. Christian Andamayo Flores, Equipo Técnico
- C.D. Sara Adelein Acosta Francia, Equipo Técnico
- C.D. Juan José Portocarrero Olano, Equipo Técnico
- C.D. Rocio del Pilar Camac Arrieta, Equipo Técnico
- C.D. Carla Sanguineti Ramírez, Equipo Técnico
- C.D. Iris Antoanet Quevedo Casquero, Equipo Técnico
- Lic. Carmen Rosa García More, Apoyo Secretarial
- Lic. Sarita Dianne Reyes Olivos, Apoyo Secretarial

Revisión y validación:

- Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
- Dirección General de Operaciones en Salud
- Dirección General de Personal de la Salud
- Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud
- Dirección Ejecutiva de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral
- Dirección Regional de Salud Moquegua
- Gerencia Regional de Salud Loreto
- Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte
- Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur
- Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este
- Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU)
- Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña (INSN)
- Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)
- Sanidad de la Marina de Guerra del Perú
- Colegio Odontológico del Perú (COP)
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
- Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV)
- Universidad de San Martin de Porres (USMP)

Para la validación de Anexos:

- Bernardo Bendezú Gavilan DIRIS LIMA NORTE
- Rolando Andía Navarro DIRIS LIMA NORTE
- Bertha Medrano Quispe DIRIS LIMA NORTE
- Melissa Orihuela Ubillúz DIRIS LIMA ESTE
- Marco Farro Valdivia DIRIS LIMA ESTE
- Yesenia Arias Amaro DIRIS LIMA ESTE
- Franklin Lozano Aquije HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE
- Diana Trujillo Salas HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

TABLA DE CONTENIDO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 5

I. INTRODUCCIÓN 8

II. FINALIDAD 9

III. OBJETIVOS 9

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 9

V. BASE LEGAL 9

VI. CONTENIDO 10

- 6.1. Definiciones Operacionales 10
- 6.2. Etiología de las Maloclusiones 12
- 6.3. Factores de Riesgo de las Maloclusiones 12
- 6.4. Promoción de la Salud Bucal 14
- 6.5. Prevención de las Maloclusiones 14
- 6.6. Clasificación de las Maloclusiones 15
- 6.7. Consideraciones generales para el Bruxismo 20
- 6.8. Manejo de pacientes con Malos Hábitos Orales 20
- 6.9. Diagnóstico de las Maloclusiones 21
- 6.10. Interconsulta relacionada a las Maloclusiones 22
- 6.11 Referencia relacionada a las Maloclusiones 23

VII. RESPONSABILIDADES 23

IX. ANEXOS 23

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 31

MINISTERIO DE SALUD

No. 641-2026/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 24 de Julio del 2026

VISTO, el Expediente N° DGIESP-DSABU20260000228, que contiene el Memorándum N° D003648-2026-DGIESP-MINSA que adjunta el Informe N° D000010-2026-DGIESP-DSABU-MINSA, y la Nota Informativa N° D001863-2026-DGIESP-MINSA que anexa las Notas Informativas N° D000180-2026-DGIESP-DSABU-MINSA y N° D000006-2026-DGIESP-DSABU-RAF-MINSA, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° D000761-2026-OGAJ-MINSA, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 1) del artículo 3 y el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establecen que el Ministerio de Salud es competente en salud de las personas, y que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1161 señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, entre otros;

Que, la Política Nacional Multisectorial de Salud "Perú, País Saludable al 2030", aprobada por Decreto Supremo N° 026-2020-SA, contempla que las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, señalando que el factor de riesgo más importante es una higiene bucodental deficiente y que el ejercicio de prácticas adecuadas de higiene bucal es una actividad poco frecuente entre la población de 1 a 11 años, a nivel nacional; por lo que, establece como

objetivo prioritario 1: Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población, orientándose a desarrollar en las personas hábitos, conductas y estilos de vida saludables con la finalidad de disminuir los factores causales de la pérdida de años de vida saludables por discapacidad o por muerte prematura, en los que tiene responsabilidad la persona y familia a través de sus conductas;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas en Salud Pública en materia de salud bucal, entre otras;

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha propuesto para aprobación el Documento Técnico: Consideraciones para la Prevención y Diagnóstico Temprano de las Maloclusiones en Niñas y Niños;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Dirección General de Operaciones en Salud, de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Despacho Viceministerial de Salud Pública y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Consideraciones para la Prevención y Diagnóstico Temprano de las Maloclusiones en Niñas y Niños, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO
Ministro de Salud

DOCUMENTO TÉCNICO: CONSIDERACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LAS MALOCLUSIONES EN NIÑAS Y NIÑOS

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades bucodentales, pese a ser en su mayoría prevenibles, representan una carga importante para el Sector Salud en muchos países y afectan a su población durante toda la vida, causando dolor, molestias, deformidades e incluso la muerte.[1]

El estudio realizado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), en febrero de 2025, "Tendencias de la carga mundial, regional y nacional de enfermedades bucodentales de 1990 a 2021", fue diseñado para monitorear el progreso hacia las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3,69 mil millones de personas en todo el mundo.[2]

La OMS, a través de la "Estrategia y plan de acción mundiales sobre salud bucodental 2023–2030", traza la hoja de ruta integral diseñada para transformar la atención odontológica a nivel global. En este documento de políticas sanitarias se agrupan las maloclusiones dentro de los trastornos bucodentales claves que afectan el bienestar, y se destaca que las maloclusiones graves alteran funciones básicas, como la masticación, la deglución, la fonación y la función de la mandíbula, además de influir negativamente en la nutrición, la estética y la calidad de vida de las personas. Se menciona también que, aunque el tratamiento ortodóntico complejo no siempre forma parte de los paquetes básicos de salud, se impulsa a los Estados miembros a capacitar al personal de la atención primaria de la salud para identificar de manera temprana las maloclusiones. [3]

Asimismo, la OMS describe a las maloclusiones como el tercer problema de mayor prevalencia en salud oral, luego de la caries dental y la enfermedad periodontal. Estas enfermedades comparten factores de riesgo con otras importantes enfermedades no transmisibles, tal como se aprobó en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la cual se aprobó la declaración política de alto nivel que establece que "*las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes*".[1,4]

El Ministerio de Salud ha formulado la Política Nacional Multisectorial de Salud "Perú, País Saludable al 2030", aprobada por Decreto Supremo N° 026-2020-SA, la cual responde efectivamente a las necesidades de la población. En los últimos años, si bien se han producido mejoras con respecto a los indicadores de pobreza y una reducción de la inequidad en salud, todavía persisten disparidades departamentales y un nivel alto de pobreza en algunas comunidades. Esto hace necesario un abordaje de los determinantes sociales de la salud que mantenga y mejore los logros ya alcanzados, al mismo tiempo que priorice a la población vulnerable. [5,6]

En el Perú, se ejecutó el Estudio de Perfil Epidemiológico de Salud Bucal (2012-2014) en la población de 3 a 15 años. Esta investigación identificó una prevalencia nacional de caries dental de 85.6%; de la enfermedad periodontal en niñas y niños de 3 a 9 años de 46.4%, y en la población de 10 a 15 años de 52.5%, mientras que la presencia de maloclusiones dentarias en la población de 6 a 15 años de edad fue de 52.2%[7].

Es importante destacar que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Bucal, del Ministerio de Salud reportó en el sistema de información HIS MINSA un total de 168,197 registros de anomalías dentofaciales (incluyendo maloclusiones) a nivel nacional entre los años 2023 al 2025. Esto representa un promedio anual aproximado 56,000 registros de maloclusiones. Estos datos evidencian que las maloclusiones constituyen un problema de salud pública en el Perú, así mismo permiten a las autoridades tomar decisiones para la asignación de recursos y el diseño de programas preventivos y la intervención temprana en la infancia, enfocados en interceptar malos hábitos orales.

Finalmente, la evidencia científica disponible reafirma que las maloclusiones no sólo son un problema estético, sino que afecta directamente la fonación, la masticación, la autoestima y la calidad de vida de los niños.

II. FINALIDAD

Contribuir a la mejora del estado de salud y de la calidad de vida de las niñas y niños, a través de la prevención y el diagnóstico temprano de las maloclusiones.

III. OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL:

Establecer los aspectos conceptuales y criterios técnicos para la prevención y diagnóstico temprano de las maloclusiones en niñas y niños.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Establecer acciones de promoción de la salud bucal y acciones para la prevención de las maloclusiones.
- Estandarizar el tamizaje sistemático mediante la Ficha de Riesgo de Maloclusiones (FRM) en los establecimientos de salud del primer nivel de atención de salud.
- Determinar los criterios para realizar la referencia de pacientes con maloclusiones.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Documento Técnico es de aplicación en los establecimientos de salud del primer nivel de atención que cuenten con cirujanos dentistas en consultorio externo de odontología del Ministerio de Salud, a cargo de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), y de los Gobiernos Regionales, a cargo de las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs), Gerencias Regionales de Salud (GERESAs) o las que hagan sus veces a nivel regional. Sirve de referencia para los establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú y de los Gobiernos Locales, así como para los establecimientos de salud privados y mixtos.

V. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Ley N° 27878, Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, y sus modificatorias.
- Ley N° 29414, Ley establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.
- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 026-2020-SA, que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”.
- Resolución Ministerial Nº 751-2004/MINSA, que aprueba la NT Nº 018-MINSA-DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 214-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 139-MINSA/2018/DGAIN: “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica”, y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial Nº 1353-2018/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Guías Alimentarias para la Población Peruana”.
- Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)”.
- Resolución Ministerial N° 559-2022/MINSA, que aprueba la NTS Nº 188-MINSA/DIGIESP-2022, Norma Técnica de Salud para el Uso de la Odontograma.
- Resolución Ministerial N° 682-2025/MINSA que aprueba la NTS N° 238-MINSA/DGIESP-2025, Norma Técnica de Salud para el control de crecimiento y desarrollo del niño.

VI. CONTENIDO

6.1. DEFINICIONES OPERACIONALES

Para efectos del presente Documento Técnico, se entiende por:

- **Abfracción dental:** Pérdida de estructura dental en la región cervical de un diente. Algunos estudios de investigación sugieren que esto se debe a fuerzas de flexión que aplican una carga biomecánica excesiva a uno o más dientes.[8]
- **Abrasión dental:** Pérdida de tejido dental no bacteriana, debido al desgaste por fricción provocado por agentes extrínsecos a través de algún proceso mecánico inusual o anormal. Las abrasiones suelen tener forma de cuña y se asocian a una herida menor en la que la superficie de la piel o la membrana mucosa se desgasta por un traumatismo por fricción.[8,9,10]
- **Apiñamiento dentario:** Alteración en la posición de los dientes debido al espacio insuficiente para los dientes en los maxilares.[8]
- **Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales:** Es un procedimiento estomatológico realizado por el cirujano dentista que consiste en la intervención educativa e individualizada, orientada a modificar los hábitos dietéticos de la persona como parte de la prevención, tratamiento y control de las enfermedades del sistema estomatognático.
- **Bruxismo:** Actividad repetitiva de los músculos masticatorios que se caracteriza por apretar y rechinar los dientes y/o por fuerzas de empuje de la mandíbula; y, se divide en bruxismo del sueño y bruxismo en vigilia (despierto). [8,12]
- **Dentición temporal:** También llamada dientes deciduos, dientes primarios o dientes de leche. Cada cuadrante de la boca tiene 5 dientes: 2 incisivos, 1 canino y 2 molares, para hacer una dentición total de 20 dientes. Los incisivos erupcionan entre los 6 y los 9 meses de edad, seguidos por los primeros molares que erupcionan a los 12–14 meses; los caninos, a los 16–18 meses; y, finalmente, los segundos molares, a 24–30 meses. Puede haber una variación considerable en las fechas de erupción, aunque la erupción de los incisivos centrales después de los incisivos laterales generalmente indica alguna patología.[8,9]
- **Dentición mixta:** Etapa de desarrollo dental en niños y niñas (aproximadamente de 6 a 12 años) cuando tienen una combinación de dientes temporales y permanentes presentes en la cavidad bucal.[9]
- **Dentición permanente:** Consta de 32 dientes formados por 3 molares, 2 premolares, 1 canino, y 2 incisivos en cada cuadrante. El primer diente en erupcionar es el primer molar alrededor de los 6-7 años de edad. La erupción de los dientes permanentes normalmente se completa entre 14 y 15 años de edad, a excepción de los terceros molares (muelas del juicio) que, por lo general, erupcionan entre los 18 y los 25 años de edad, pudiendo retrasarse considerablemente o no erupcionar.[8,9]
- **Evaluación oral completa:** Procedimiento realizado por el cirujano dentista, que comprende la evaluación integral, rigurosa y minuciosa de los tejidos duros y blandos, extraorales e intraorales, así como de los órganos y estructuras que comprenden el sistema estomatognático; de ser necesario, se realiza la evaluación del historial médico y estomatológico, de la interpretación de exámenes y/o procedimientos de apoyo al diagnóstico, y de interconsultas, si se requiere una evaluación del estado de salud general del paciente; incluye la detección de signos de cáncer o de afecciones precancerosas. Comprende el registro de los hallazgos de la evaluación en la historia clínica.
- **Factores de riesgo:** Características y circunstancias detectables que aumentan la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto al proceso de una enfermedad. [15]
- **Hábitos orales:** Son conductas repetitivas realizadas con las estructuras orofaciales; estas pueden presentarse de forma temporal o permanente; pueden ser perjudiciales cuando se repiten en exceso, resultando en un impacto negativo en las funciones orales y posturales, como son succión no nutritiva (succión de pulgar, uso de chupete o chupar otros objetos,), bruxismo, deglución y posición anormal de la lengua, respiración bucal,

lamerse los labios, morderse la lengua, las uñas y las mejillas.[10,16,17]

- **Incompetencia labial:** Incapacidad de mantener los labios cerrados de forma natural cuando la mandíbula está en reposo.[9]
- **Línea media dentaria superior:** Relación de las caras mesiales de los incisivos centrales superiores con respecto a la línea media facial.[17]
- **Línea media dentaria inferior:** Relación de las caras mesiales de los incisivos centrales inferiores con respecto a la línea media facial.[17]
- **Maloclusión:** Resultado de la anormalidad morfológica y funcional de los componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema estomatognático. Se define como una desviación de los dientes o una mala relación de los arcos fuera del rango normal aceptado.[8,9]
- **Overbite:** Distancia vertical entre los bordes incisales de los incisivos maxilares y mandibulares cuando el paciente está en oclusión. Se mide en porcentaje que el incisivo superior cubre al inferior y debería ser un número positivo, aproximadamente 30%. Cuando es negativo, se llama mordida abierta.[18]
- **Overjet:** Distancia sagital (horizontal) entre los bordes incisales de los incisivos maxilares y mandibulares cuando el paciente está en oclusión. Este debería ser un número positivo, aproximadamente 2mm. Cuando es negativo, se llama overjet negativo, o mordida cruzada anterior. [18]
- **Pérdida prematura de diente temporal:** Pérdida de la pieza dentaria antes del tiempo de exfoliación natural o antes de que el sucesor permanente haya llegado a la formación coronaria completa y al inicio de la formación radicular. Pueden ocasionar maloclusiones, mala pronunciación, problemas de masticación, daño periodontal, falta de crecimiento del hueso alveolar y un aspecto desfavorable en cuanto a la estética que repercute en la autoestima del paciente.[13,19]
- **Plano coronal o frontal:** También llamado plano vertical, permite evaluar la dimensión vertical (mordida abierta - mordida profunda).[20]
- **Plano transversal u horizontal:** Permite evaluar la congruencia de las arcadas superior e inferior (mordidas cruzadas), así como movimientos mandibulares a la derecha o izquierda.[20]
- **Plano sagital:** También llamado plano antero-posterior, permite evaluar la clase esquelética y dentaria sea I, II o III.[21]
- **Plano terminal:** Los planos terminales son las superficies distales de las segundas molares deciduas. Los 3 planos terminales pueden ser:[21]
    - **Plano terminal recto** (dentición decidua), esto se da cuando la relación de las caras distales de las segundas molares deciduas está al mismo nivel. [21]
    - **Plano terminal escalón mesial** (dentición decidua), esto se da cuando la relación de la cara distal de la segunda molar decidua inferior está a mesial respecto a la cara distal de la molar decidua superior. [21]
    - **Plano terminal escalón distal** (dentición decidua), esto se da cuando la relación de la cara distal de la segunda molar decidua inferior está a distal respecto a la cara distal de la molar decidua superior. [21]
- **Salud bucal:** Es un estado exento de dolor, enfermedades o trastornos en la cavidad bucal del sistema estomatognático que limiten a una persona la capacidad de hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, tragar, así como transmitir una serie de emociones a través de expresiones faciales con confianza.[22]
- **Tratamiento temprano de las maloclusiones:** Terapia ortodóncica realizada durante los estadios más activos del crecimiento dentario y esquelético; se inicia en dentición primaria y mixta con el fin de mejorar el desarrollo dentoesquelético conducente a la corrección e intercepción de la maloclusión, reduciendo la necesidad y/o tiempo de tratamiento en la dentición permanente.[23,24]

6.2. ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES

Las maloclusiones se definen como un trastorno multifactorial originado por la interacción de diversos elementos genéticos, ambientales y estilos de vida que se sobreponen durante el desarrollo craneofacial. Su etiología se centra principalmente en 2 componentes: La herencia genética y los factores locales o ambientales, cuya influencia recíproca determina la manifestación clínica de la patología. Por ello, resulta indispensable que el cirujano dentista analice minuciosamente estos fenómenos para neutralizarlos de forma efectiva, asegurando así el éxito terapéutico y minimizando el riesgo de recidivas tras el tratamiento.[25]

6.3. FACTORES DE RIESGO DE LAS MALOCLUSIONES

La prevalencia de maloclusiones dentarias y esqueléticas responde a la interacción entre la predisposición genética y factores ambientales o de comportamiento. Estos agentes actúan desde el periodo neonatal e interfieren en los procesos evolutivos del sistema estomatognático. Los hábitos orales nocivos y las condiciones preexistentes constituyen los principales riesgos para la integridad de las denticiones temporal y permanente, al exacerbar las anomalías durante el crecimiento. [25,26,27,28,29,30,31]

La mitigación del riesgo clínico exige la identificación y neutralización de estos factores mediante protocolos de intervención temprana. La estrategia terapéutica se basa en un manejo interceptivo adaptado a la madurez biológica del paciente, lo cual garantiza la estabilidad del desarrollo oclusal y previene el agravamiento de la condición clínica.[28,29,30]

Estos factores de riesgo de la maloclusión están asociados a lo siguiente:

6.3.1. Medio ambiente

El entorno ambiental y las condiciones socioeconómicas influyen directamente en la salud bucal de la niña y del niño; factores, como la calidad de la vivienda, la higiene inadecuada y la dificultad para acceder a servicios básicos (agua potable, atención médica y educación) son determinantes. [26,27,29]

Adicionalmente, la malnutrición y el ambiente psicosocial del hogar y la comunidad donde crece la niña y el niño pueden tener consecuencias, tanto en su salud física como en su desarrollo psicológico.[26]

6.3.2. Estilo de vida y conducta

Los hábitos adquiridos durante la infancia temprana representan determinantes críticos para la salud sistémica y bucodental. El consumo excesivo de carbohidratos fermentables, grasas y sodio establecen una dieta cariogénica que, en conjunto con una higiene oral deficiente, conducen a la pérdida prematura de la dentición temporal. Este evento, ocurrido antes de la maduración radicular del diente sucesor, altera el espacio en la arcada al provocar la migración e inclinación de los dientes adyacentes y antagonistas.[19,26]

De igual manera, la persistencia de hábitos orales nocivos altera el equilibrio del desarrollo maxilofacial. La succión no nutritiva digital o de objetos destaca como la práctica de mayor prevalencia en ausencia de una lactancia materna prolongada, vinculándose directamente con la aparición de maloclusiones. Asimismo, factores, como la respiración bucal, la deglución atípica y la onicofagia se relacionan con el apiñamiento dentario, mientras que el estado nutricional de la niña y del niño incide directamente en las posibles alteraciones de la erupción dental, por lo que la erupción dental puede ser una de las manifestaciones de la deficiencia nutricional crónica, la cual podría convertirse en un valioso indicador del desarrollo general en las niñas y en los niños.[32]

Finalmente, las condiciones socioculturales y el nivel educativo condicionan la conducta de los cuidadores. El desconocimiento y el temor al tratamiento odontológico derivan en una falta de importancia hacia la dentición de la niña y del niño. En consecuencia, la asistencia profesional se posterga hasta la aparición de

sintomatología dolorosa, priorizando procedimientos recuperativos sobre la prevención y el mantenimiento de la salud bucal.[19,33]

6.3.3. Factor hereditario

Las maloclusiones de clase I y clase II tienen una etiología principalmente ambiental, sin antecedentes genéticos significativos a diferencia de la clase III que es menos común, pero es la de mayor carga hereditaria.[34]

La clase III se hereda de manera poligénica (varios genes) pero también existe evidencia de herencia monogénica (único gen), donde la morfología esquelética del complejo dentofacial depende de la interacción entre genes de susceptibilidad y los factores ambientales (gen-ambiente) que resultan en el fenotipo de clase III.[35]

Dado que un componente genético marcado incrementa la complejidad del tratamiento, su detección temprana es esencial. Un diagnóstico oportuno no sólo permite planificar una intervención más eficiente, sino que también reduce significativamente el tiempo de tratamiento y mejora la calidad de vida del paciente.[36,37]

6.3.4. Factores preexistentes y/o locales

Existen factores que inciden en el desarrollo de la cavidad bucal y actúan como precursores de las maloclusiones. Cuando las anomalías locales, como la caries, las extracciones, los hábitos nocivos, la anquilosis, o la erupción tardía, entre otras, no reciben una intervención oportuna, el riesgo de establecimiento de las maloclusiones aumenta. [33]

Un ejemplo clínico crítico es la mordida cruzada anterior en edades tempranas; de no ser tratada, puede derivar en una clase III esquelética. Otra afección clínica, como la biprotrusión actúa como un factor determinante y predisponente de maloclusiones graves, a menudo combinada con incompetencia labial, tensión muscular y afectación de la vía aérea. Asimismo, un hábito de succión digital persistente se convierte en un factor de riesgo para el desarrollo de una clase II esquelética o una mordida abierta de carácter estructural.[38,39,40]

Entre los principales factores se encuentran:

- El bruxismo: Actúa como un factor coadyuvante en la presencia y agravamiento de las maloclusiones. [40]
- Los malos hábitos orales: Comportamientos parafuncionales que alteran el equilibrio muscular y óseo.[39,40]
- La pérdida prematura de dientes: Ya sea en dentición temporal o permanente, causada por la caries, las extracciones dentales o los traumatismos. Esta pérdida se considera un factor de riesgo preexistente debido a que desencadena una cascada de alteraciones:
    - Funcionales: Maloclusión, dificultades en la fonación y problemas de masticación.
    - Estructurales: Daño periodontal, falta de desarrollo del hueso alveolar y cambios en las relaciones esqueléticas. [41,42]
    - Psicosociales: Alteración estética que repercute negativamente en la autoestima del paciente afectando su calidad de vida. [43,44.]

6.3.5. Factor sistémico

Son condiciones o enfermedades generales que pueden interferir en el crecimiento y desarrollo del complejo craneofacial, alterando el equilibrio neuromuscular y funcional del sistema estomatognático. Dentro de estos factores se incluyen las alteraciones respiratorias crónicas, como rinitis, sinusitis, asma, hipertrofia adenoidea y otras condiciones que generan obstrucción de las vías aéreas superiores, favoreciendo patrones de respiración bucal que pueden contribuir al desarrollo de alteraciones oclusales.

6.4. PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL

6.4.1. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención realiza actividades promocionales dirigidas a la niña y al niño, así como al padre, madre, tutor y/o cuidador. Mediante estas actividades se promueven y socializan intervenciones de salud en los diferentes escenarios de intervención: Institucional, familiar, educativo, laboral y comunitario, con la finalidad de fomentar prácticas y entornos saludables que contribuyen a la higiene oral, como la intervención más importante para prevenir las maloclusiones. [41,42]

6.4.2. Para realizar las actividades de promoción de la salud bucal, el cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención desarrolla sesiones educativas y demostrativas, según lo contemplado en los Anexos 1 y 2.

6.4.3. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención comunica, instruye, motiva y educa a la niña y al niño, así como al padre, madre, tutor y/o cuidador, según corresponda, sobre la importancia de la higiene bucal en la salud general, enfatizando en la afectación de la calidad de vida de la niña y del niño debido al impacto psicológico y social que genera las maloclusiones persistentes no tratadas.[41,42,43,44]

6.4.4. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención informa a la gestante y a la madre lactante sobre la importancia del cuidado de su salud bucal durante el embarazo y sobre la importancia de promover, proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, ya que se considera como un factor protector para la prevención de las maloclusiones.[16,46,47,48,49] Asimismo, se les informa de la importancia de la cronología de erupción. [53]

6.4.5. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención realiza la capacitación al personal de la salud y a los agentes comunitarios de salud, fortaleciendo sus conocimientos en la práctica de hábitos saludables en salud bucal y la importancia de mantener una adecuada higiene oral, ya que la participación de estos actores es de suma importancia para la sensibilización de la población en temas de salud, conforme lo señalado en el Anexo 4. [51]

6.4.6. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención coordina con los actores sociales y realiza actividades en diferentes escenarios con dinámica social que brinden oportunidades de intervenciones promocionales de amplio alcance de salud bucal, como en cunas, jardines, instituciones educativas, viviendas y municipios. [5]

6.5. PREVENCIÓN DE MALOCLUSIONES

6.5.1. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención identifica tempranamente los factores de riesgo que puedan contribuir al desarrollo de una maloclusión, independientemente del motivo de consulta, mediante las siguientes acciones de prevención:

- Informa a la niña y al niño, así como al padre, madre, tutor y/o cuidador, según corresponda, sobre la importancia del cuidado de la salud bucal y el riesgo que se presenta de padecer maloclusiones.[19,26,33]
- Comunica a la niña, al niño, padre, madre, tutor y/o cuidador, según corresponda, sobre las causas y consecuencias de las maloclusiones, así como cualquier dificultad o situación desfavorable que lo predisponga a tener un riesgo de maloclusión. [24,25]
- Educa a la niña, al niño, padre, madre, tutor y/o cuidador, según corresponda, sobre las formas de prevenir las maloclusiones (evitar malos hábitos orales y realizar higiene bucal adecuada) y la importancia de acudir al cirujano dentista especialista (ortodoncista u odontopediatra) para el tratamiento temprano de la maloclusion.[52]

6.5.2. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención realiza la

evaluación oral completa y ejecuta los procedimientos preventivos según plan de tratamiento establecido, que incluye instrucción de higiene oral, asesoría nutricional para el control de enfermedades de la cavidad bucal, profilaxis dental, aplicación de flúor y sellantes, según se requiera. [25]

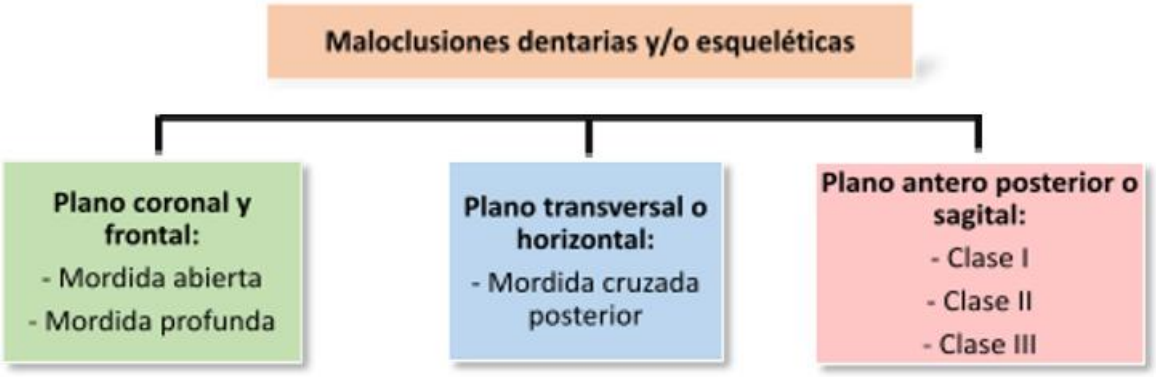
6.5.3. El cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención informa a los padres, madres, tutores y/o cuidadores sobre los posibles efectos de los hábitos orales, la importancia de un diagnóstico temprano, la intervención oportuna y la prevención; recomendando evitar el uso prolongado del chupón/tetina debido al alto riesgo de desarrollar maloclusiones como clase II canina y mordida cruzada posterior.[16,53,54,55]

6.5.4. El cirujano dentista complementa las acciones para la prevención de las maloclusiones con lo descrito en el Anexo 3.

6.6. CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES

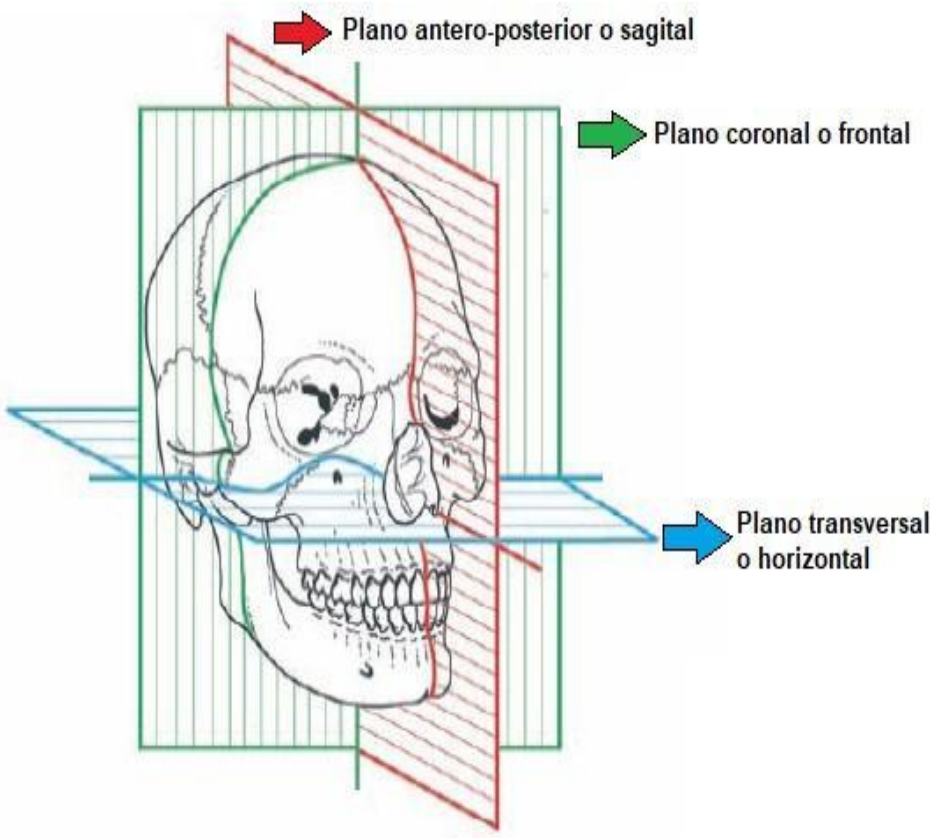
Se presenta una clasificación simple de las maloclusiones dentarias y esqueléticas, en base a los 3 planos del espacio; es importante indicar que una maloclusión puede tener 1, 2 ó 3 planos del espacio afectados a la vez:[17,42]

Tabla N° 1: Clasificación de las maloclusiones en los 3 planos del espacio (planos frontal, transversal y sagital). [17]



Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

Imagen Nº 1: Planos del espacio



6.6.2. Síntomas comunes presentes en las maloclusiones[17,25,56]

- Dolor en la región de Articulación Témporo-Mandibular (ATM).
- Dolor en músculos del sistema craneofacial.
- Limitación en la función en movimientos mandibulares.
- Sensación de mayor apretamiento de dientes nocturno (bruxismo).
- Dolor en uno o más dientes.

6.6.3. Signos comunes presentes en las **maloclusiones** [17,26,56]

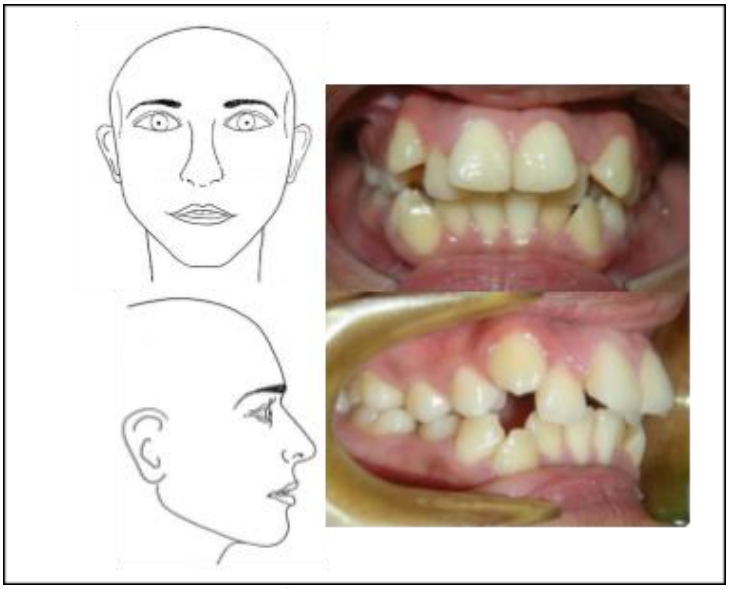
- Mal posición dentaria y pérdida de la línea media.
- Problemas dentarios: Abrasiones dentales, abfracciones, fracturas, lesiones de caries dental, migración dentaria, apiñamiento dentario.
- Problemas periodontales: Pérdida de hueso, pérdida de soporte óseo, recesiones gingivales, movilidad dentaria.
- Problemas articulares: Ruidos (chasquidos o crepitaciones) presentes en la ATM durante la dinámica mandibular y el ciclo masticatorio.

Principales signos de las maloclusiones

Maloclusión clase I

- Generalmente asociada a apiñamientos dentario, diastemas, biprotrusión dentaria, mordida abierta o profunda, mordida cruzada posterior unilateral o bilateral, desviación de línea media dentaria, entre otros.
- Relación molar de Angle clase I.
- Perfil facial ligeramente convexo durante la dentición temporal (decidua) y mixta con tendencia a recto al completar la dentición permanente.
- Pudiendo coexistir con las características de una maloclusión dentaria clase I.
- Adicionalmente, presentan los síntomas y signos comunes a toda maloclusión. [17,42,43,56,61]

Imagen N° 2: Paciente con maloclusión clase I con un perfil ligeramente convexo durante la dentición decidua y mixta haciéndose recto al completar la dentición permanente, relación molar Clase I, biprotrusión dentaria y apiñamiento dentario.

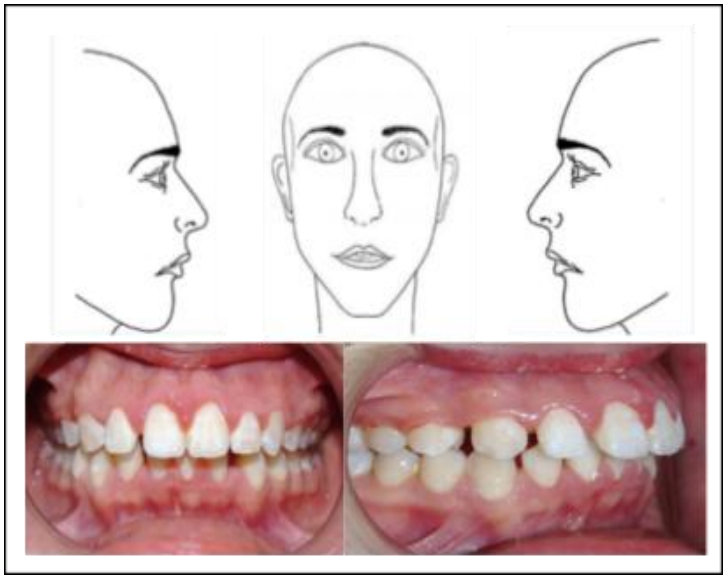


Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

Maloclusión clase II

- Generalmente asociada a incisivos superiores vestibularizados, overjet aumentado.
- Relación molar de Angle clase II.
- Paladar comprimido (ojival).
- Desequilibrio de la musculatura labial (incompetencia labial).
- Otros hallazgos que pueden estar presentes como apiñamiento dentario, mordida profunda, mordida abierta, mordida cruzada, desviación de línea media dentaria.
- Adicionalmente, puede presentar los síntomas y signos comunes a toda maloclusión o estar frecuentemente asociado a malos hábitos orales.
- Perfil facial convexo durante la dentición temporal (decidua), mixta y permanente.[17,42,43,56,61]

Imagen N° 3: Paciente con maloclusión clase II con un perfil facial marcadamente convexo durante la dentición decidua, mixta y permanente, causada por una protrusión maxilar, retrusión mandibular o combinación de ambas

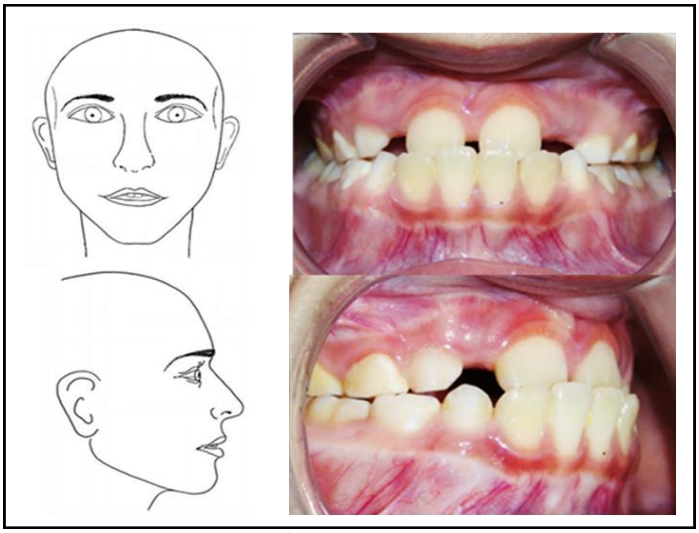


Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

Maloclusión clase III

- Generalmente asociada a mordida cruzada anterior, overjet y overbite negativos.
- Relación molar clase III (dentición permanente).
- Otros hallazgos que pueden estar presentes, como apiñamiento dentario, mordida profunda, mordida abierta, mordida cruzada, desviación de línea media dentaria.
- Adicionalmente, puede presentar los síntomas y signos comunes a toda maloclusión o estar asociado a malos hábitos orales.[17,42,43,56,61]

Imagen N°4: Paciente con maloclusión clase III esquelética con un perfil facial generalmente cóncavo durante la dentición decidua, mixta y permanente por una retrusión maxilar, protrusión mandibular o combinación de ambas

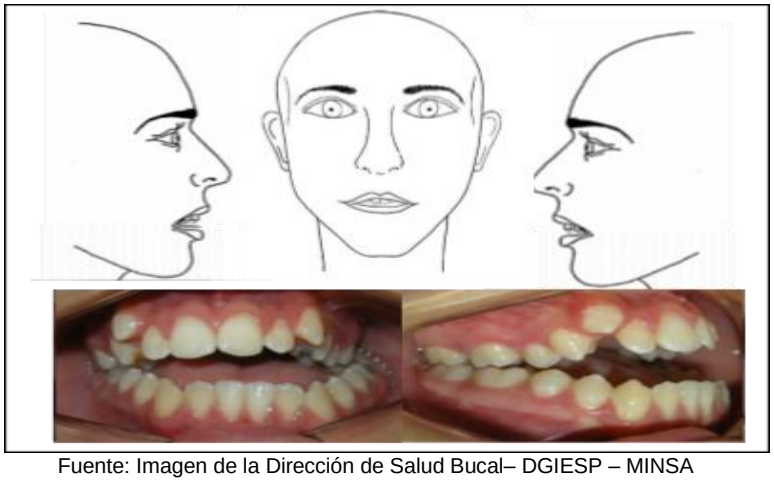


Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

Mordida abierta anterior

- Presenta overbite negativo (ausencia de sobrepase vertical de incisivos).
- Cuando la mordida abierta anterior es dentaria, generalmente se asocia a biprotrusión de incisivos.
- Cuando la mordida abierta anterior es esquelética, presenta el tercio facial inferior aumentado, cara larga.
- Adicionalmente, puede presentar los síntomas y signos comunes a toda maloclusión o estar frecuentemente asociado a malos hábitos orales.[17,42,43,56,61]

Imagen N°5: Paciente con mordida abierta anterior de tipo esquelética, obsérvese las proporciones faciales que se encuentran alteradas (cara larga)

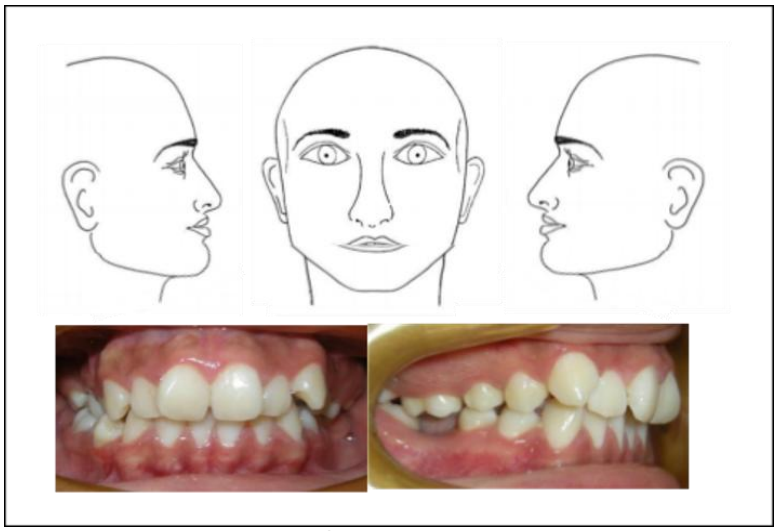


Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal– DGIESP – MINSA

Mordida profunda

- Presenta overbite aumentado.
- Cuando la mordida profunda es dentaria, generalmente se encuentra asociado a incisivos palatinizados.
- Adicionalmente, puede presentar los síntomas y signos comunes a toda maloclusión o estar raramente asociado a malos hábitos orales.
- Cuando la mordida profunda es esquelética, presenta el tercio facial inferior disminuido, cara corta. [17,42,43,56,61]

Imagen N°6: Paciente con mordida profunda esquelética, obsérvese las proporciones faciales que se encuentran alteradas (cara corta)



Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

Mordida cruzada posterior

- Molares maxilares ocupan una posición hacia lingual respecto a su posición normal, ocasionando una mordida cruzada (unilateral o bilateral). Generalmente asociada a una inclinación hacia lingual del eje de dientes posteriores maxilares.
- Otros hallazgos que pueden estar presentes son desviación de línea media dentaria.
- Adicionalmente, puede presentar los síntomas y signos comunes a toda maloclusión o estar asociado a malos hábitos orales.
- En algunos casos, la anchura de la base ósea maxilar presenta una forma de “V”. [17,42,43,56,61]

Imagen N°7: Paciente con mordida cruzada posterior unilateral de tipo dentaria, nótese la forma de arco amplia en forma de “U” y en la vista frontal la inclinación de las molares posteriores izquierdas hacia lingual



Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

6.7. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL BRUXISMO [57,58,59,60,61]

El bruxismo puede estar presente en personas sanas, sólo por un periodo de tiempo y después desaparecer; el comportamiento prolongado puede ser un factor de riesgo coadyuvante para la presencia de maloclusiones.[9]

Tener en cuenta que:

✓ El bruxismo produce un crecimiento y desarrollo anormal del complejo dentolabial, produciendo arcos maxilares estrechos, mordidas abiertas o cruzadas e incisivos superiores protruidos. [57,58]

✓ El bruxismo, al realizar movimientos excursivos, impide una oclusión dentaria balanceada, que conlleva a síntomas que se deben tomar en cuenta como indicadores de dicho comportamiento; los más comunes son la presencia de fatiga y dolor muscular de la mandíbula, dolor en la ATM y de los músculos craneofaciales. [59,60,61]

✓ El bruxismo también presenta signos, como daño a los tejidos dentales duros (por ejemplo, dientes agrietados), fallas repetitivas en los procedimientos de restauración dentales o en las prótesis dentales, desgaste dentario y problemas periodontales.[57,62]

✓ Considerar la relación entre la ansiedad y la aparición de bruxismo en vigilia y bruxismo del sueño para tomar las medidas pertinentes y, si fuera el caso, la interconsulta con un profesional en psicología. [59,60,61]

Signos y síntomas de presencia de bruxismo [57,58,59,60]

- Desgaste dentario.
- Dolor de cabeza temporal.
- Fatiga muscular o dolor muscular transitorio generalmente en la mañana.
- Bloqueo de la mandíbula al despertar.
- Rechinar los dientes.
- Fallas repetitivas en tratamientos recuperativos (restauraciones, prótesis dentales).

6.8. MANEJO DE PACIENTES CON MALOS HÁBITOS ORALES

- Si la niña y el niño se encuentra en la etapa de dentición temporal, el cirujano dentista del

establecimiento de salud del primer nivel de atención debe recomendar al padre, madre, tutor y/o cuidador que se evite el uso de chupón/tetina, ya que existe mayor riesgo de desarrollar maloclusiones, como la clase II canina y la mordida cruzada posterior. [53]

- En dentición mixta, se debe controlar el uso prolongado del hábito de succión no nutritiva (uso de chupón o succión digital), ya que, a mayor duración del hábito de succión, existe mayor riesgo de desarrollo de maloclusiones, como mordida cruzada posterior y mordida abierta anterior. [53,61,63]

- Si la niña y el niño es mayor de 3 años y no ha logrado detener el mal hábito y este ha causado una deformación orofacial, se realiza la interconsulta al cirujano dentista especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. En caso de no contar con este especialista, se realiza la interconsulta al odontopediatra, según la necesidad del paciente y en el marco de las competencias del especialista.[62,63]

- Si la niña y el niño es menor de 3 años, realiza consejería con material ilustrativo didáctico para la edad de la niña y del niño, e informa al padre, madre, tutor y/o cuidador sobre los malos hábitos orales y sus consecuencias negativas en la salud bucal.[63]

- Los malos hábitos se presentan como un factor que contribuye en el desarrollo de maloclusiones, por lo que el cirujano dentista del establecimiento de salud del primer nivel de atención debe identificar sus signos de manera temprana durante la atención al niño.[12,40,57]

  Signos frecuentes de malos hábitos orales [53,54,55]

  - La succión no nutritiva (succión digital o de otro objeto como el chupón).
  - Deglución atípica por interposición lingual o labial.
  - Respiración bucal.
  - Onicofagia.
  - Hábitos de mala postura.
  - Lamerse los labios.
  - Morderse la lengua.

- El cirujano dentista instruye al padre, madre, tutor y/o cuidador para que realicen lo siguiente:

  - Indicar y enfatizar al niño y a la niña, según corresponda, cuando realice el mal hábito oral, la importancia de su cooperación.
  - Elogiar y premiar a la niña y al niño, según corresponda, cuando se observe una mejora respecto al mal hábito oral (por ejemplo, premiar por cada día sin realizarlo)
  - Realizar el monitoreo y registro manual en una hoja de la duración, frecuencia e intensidad del mal hábito oral que realiza la niña y el niño, con la finalidad de evaluar el progreso en la corrección. [58,60]

- En el caso que la niña y el niño use chupón/tetina, el cirujano dentista indica a los padres, tutores y cuidadores que su uso debe ser eliminado.

6.9. CONSIDERACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS MALOCLUSIONES

Para determinar el diagnóstico presuntivo o definitivo de maloclusiones y la presencia de factores de riesgo, el cirujano dentista del establecimiento de salud debe realizar una evaluación oral completa. Asimismo, registra los hallazgos en la historia clínica y en la ficha odontoestomatológica o la que haga sus veces, la cual es firmada y sellada por el profesional.

Asimismo, el cirujano dentista realiza el registro en la FRM para identificar parámetros clínicos, como signos, presencia de malos hábitos orales y/o bruxismo, entre otros hallazgos; estos sirven para el diagnóstico presuntivo de las maloclusiones o determinar el riesgo de estas que presenta la niña y el niño.

La FRM se realiza anualmente junto a la evaluación oral completa. Durante el primer año de vida se debe realizar la primera visita al cirujano dentista se antes de la erupción de los dientes temporales, con la finalidad de evaluar y descartar la existencia de anomalías en el paladar, los labios o los frenillos.

El cirujano dentista realiza el registro en la FRM de acuerdo a lo señalado en el Anexo 5; debiendo considerar lo siguiente:

a) Edad del niño y de la niña:

- En niñas y niños desde los 0 hasta los 2 años, 11 meses y 29 días de edad, se utiliza la Parte I de la FRM.
- En niñas y niños desde los 3 hasta los 11 años, 11 meses y 29 días de edad, se utiliza la Parte II de la FRM.

b) La FRM contiene cuadrantes por cada hallazgo clínico, en la cual se visualizan áreas sombreadas y no sombreadas; en el caso que se identifique una o más áreas sombreadas, se considera como presuntiva la presencia de maloclusiones o el riesgo de padecerlas.

c) Para el registro en la FRM, considerar la sintomatología y signos comunes de las maloclusiones.

d) Identificar a los pacientes que tengan malos hábitos orales y los episodios de bruxismo, ya que se consideran como un factor de riesgo para desarrollar o agravar la maloclusión.

e) Identificar a niños y niñas que hayan perdido de forma prematura las piezas dentarias temporales, ya que puede conducir a movimientos dentales indeseables de los dientes temporales y/o permanentes, provocando una disminución del espacio reservado para los sucesores permanentes, debido a la migración de los dientes adyacentes, ocasionando acortamiento de la longitud de la arcada.[19]

f) Identificar los 3 planos del espacio, considerando que pueden estar afectados 2 o 3 planos simultáneamente.[17,61]

6.10. INTERCONSULTA RELACIONADA A MALOCLUSIONES

a) Si luego de la evaluación oral completa del recién nacido, el cirujano dentista identifica la presencia de anomalías en paladar, labios, frenillos y otros, realiza las coordinaciones para su interconsulta por los servicios/departamentos de atención gineco-obstétrica, pediatría, neonatología y de enfermería, según corresponda, para la atención del recién nacido. [53]

b) El cirujano dentista realiza las coordinaciones con el profesional responsable del servicio de Crecimiento y Desarrollo (CRED) del establecimiento de salud para la a interconsulta de los niños y de las niñas por el servicio o departamento de odontología, estomatología o el que haga sus veces, cuando durante la evaluación de CRED se identifique algún signo de mal habito oral en la niña o el niño.[5]

c) El cirujano dentista realiza las coordinaciones con el servicio de nutrición para la adecuada interconsulta al niño y la niña, bajo el enfoque de cuidado integral, pues la desnutrición en niñas y niños afectan el desarrollo y/o crecimiento cráneo facial, especialmente en los maxilares y dientes; provocando alteraciones en la erupción dentaria, predisposición a desarrollar caries dental, problemas periodontales, malos hábitos orales, entre otras alteraciones; lo cual repercute en la cavidad bucal y el desarrollo de una maloclusión.[32]

d) El cirujano dentista realiza la interconsulta de la niña y del niño con diagnóstico presuntivo

de maloclusión al cirujano dentista especialista de ortodoncia y ortopedia maxilar o especialista en odontopediatría, según la necesidad del paciente y en el ámbito de sus competencias, para el adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento según corresponda.

e) El cirujano dentista que identifique dificultades del habla y lenguaje en la niña y el niño, realiza la interconsulta con el profesional especialista en terapia de lenguaje.

6.11. REFERENCIA RELACIONADA A MALOCLUSIONES

a) Los profesionales de la salud de los establecimientos de salud en los que no se cuente con cirujano dentista, deben realizar la referencia de los niños y niñas al servicio o departamento de odontología, estomatología o el que haga sus veces para la evaluación oral completa y el diagnóstico temprano de las maloclusiones.

b) Cuando el establecimiento de salud no cuente con el especialista de ortodoncia y ortopedia maxilar o especialista en odontopediatría, el cirujano dentista realiza la referencia de la niña y del niño con diagnóstico presuntivo de maloclusión a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva que cuenta con los especialistas.

c) Cuando el establecimiento de salud no cuente con el especialista en terapia de lenguaje, el cirujano dentista realiza la referencia de la niña o el niño que presente dificultades del habla y lenguaje a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva que cuenta con el especialista.

d) Previa a la referencia de la niña y del niño con diagnóstico de maloclusiones, el cirujano dentista del establecimiento de salud realiza los procedimientos estomatológicos hasta brindar el alta básica odontológica e instaurar la práctica de buenos hábitos de higiene bucal en la niña y en el niño.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1 NIVEL NACIONAL

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (Dirección de Salud Bucal), es responsable de la difusión del presente documento normativo hasta el nivel regional, así como de brindar la asistencia técnica para su implementación y supervisar su cumplimiento.

7.2 NIVEL REGIONAL

Las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS), Gerencias Regionales de Salud (GERESAS) o las que haga sus veces a nivel regional, son responsables de la difusión, asistencia técnica, implementación y supervisión de la aplicación del presente documento normativo.

7.3 NIVEL LOCAL

Los establecimientos de salud del primer nivel de atención de salud dan cumplimiento a lo dispuesto en el presente documento normativo, de corresponder.

VIII. ANEXOS

Anexo 1: Sesión educativa.
Anexo 2: Sesión demostrativa.
Anexo 3: Consideraciones para el cirujano dentista.
Anexo 4: Capacitación al personal de la salud y agentes comunitarios de salud.
Anexo 5: Ficha de riesgo de maloclusiones

ANEXO 1: SESIÓN EDUCATIVA[13,62]

- ✓ Informar al padre, madre, tutor y/o cuidador la importancia de la salud bucal y las repercusiones que tiene en la calidad de vida de la niña y del niño.
- ✓ Informar al padre, madre, tutor y/o cuidador que los factores de riesgo para la presencia de las maloclusiones dentarias y esqueléticas son principalmente factores genéticos, medioambientales y de estilos de vida; por lo que, se considera una enfermedad multifactorial, que actúa desde el nacimiento. Estos factores afectan el proceso evolutivo de las denticiones temporales y permanentes, contribuyendo al desarrollo de las maloclusiones.
- ✓ Recomendar la lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida, ya que esto fomenta un adecuado crecimiento craneofacial en la niña y el niño.
- ✓ Informar al padre, madre, tutor y/o cuidador sobre los malos hábitos orales, como la succión no nutritiva (succión digital, uso de chupón o chupar otros objetos, tales como mantas o juguetes), bruxismo patológico, deglución y posición anormal de la lengua, respiración bucal, lamerse los labios, morderse la lengua, las uñas y las mejillas; comportamientos de autolesión y automutilación; provocando deformaciones en el área bucal.
- ✓ Instruir al niño y a la niña según su edad, y concientizar e instruir al padre, madre, tutor o cuidador que el cepillado de dientes es una de las acciones más importantes para el control de las enfermedades bucales, entre ellas las maloclusiones por pérdida prematura de dientes por caries dental. Asimismo, recomendar al padre, madre, tutor o cuidador que, ante la presencia de algún mal hábito oral, debe acudir al cirujano dentista para su evaluación y corrección.
- ✓ Recomendar al padre, madre, tutor o cuidador que, ante la pérdida prematura de un diente (por caries, traumatismo u otra causa), la niña y el niño sea evaluado oportunamente por un cirujano dentista especialista (ortodoncista u odontopediatra) para recibir el tratamiento preventivo que asegure el desarrollo normal de su dentición y garantice el espacio necesario para la correcta salida de los dientes permanentes.
- ✓ Indicar al padre, madre, tutor y/o cuidador que la niña y el niño debe acudir al cirujano dentista en los primeros meses de vida, sobre todo antes de cumplir el primer año de vida.
- ✓ Indicar al padre, madre, tutor y/o cuidador la importancia de una buena alimentación del niño y de la niña para un adecuado desarrollo craneofacial.
- ✓ Informar al padre, madre, tutor y/o cuidador sobre la cronología de la erupción dental y su importancia.
- ✓ Recomendar a los padres y/o cuidadores que, si observa algún retraso en la erupción de los dientes, anormalidad en el rostro (cara torcida) o en las estructuras orales (labios, paladar) de la niña y el niño, acuda al cirujano dentista para una evaluación.
- ✓ Recomendar a al padre, madre, tutor o cuidador la visita al cirujano dentista de la niña y del niño por lo menos 2 veces al año.

**En esta sesión se puede utilizar material audiovisual u otros recursos didácticos para fortalecer el aprendizaje*

Fuente: Elaboración propia – Dirección de Salud Bucal de la DGIESP - MINSA

ANEXO 2: SESIÓN DEMOSTRATIVA[13,62]

- ✔ Instruir al padre, madre, tutor y/o cuidador sobre las mejores maneras de realizar la remoción efectiva de la placa dental de los dientes de las niñas y de los niños; esto incluye una demostración práctica delante del cirujano dentista: Debe aprovechar este momento para enseñar las áreas donde se encuentra mayor acúmulo de placa dental, y se ejecute un cepillado dental más efectivo, también debe fomentar el uso del hilo dental; y, resaltar las indicaciones y contraindicaciones del uso de los enjuagatorios bucales.
- ✔ Indique al padre, madre, tutor y/o cuidador, mediante el uso de materiales de apoyo, que debe realizar el cepillado dental por todas las superficies de los dientes del niño y de la niña de forma ordenada, empezando con los dientes del maxilar superior y después con el maxilar inferior, asegurándose que todos los restos alimenticios sean removidos y no olvidar de la limpieza de la lengua. El cepillado dental no debe ser menor a 2 minutos, al menos 2 veces al día, sobre todo antes de dormir.
- ✔ Los niños y niñas que, de acuerdo a su edad tengan la capacidad de poder realizar el cepillado dental y la higiene de la boca por sí mismo, ejecutan las indicaciones descritas en los párrafos anteriores. En este caso, se indica al padre, madre, tutor y/o cuidador que realice la supervisión y acompañamiento.
- ✔ En el caso que exista contacto entre los dientes adyacentes, se pueda recomendar el uso de hilo dental; se le enseña al padre, madre, tutor y/o cuidador el uso adecuado que debe realizar la niña y el niño, el cual se realiza antes del cepillado dental.
- ✔ Solicitar al padre, madre, tutor y/o cuidador que practique en la maqueta dental y realice la limpieza como se indicó anteriormente; lo puede hacer el niño y la niña, en caso tenga la capacidad de realizarlo.
- ✔ Recomendar al padre, madre, tutor y/o cuidador que la niña y el niño utilice una pasta dental que contenga fluoruro, entre 1000 a 1500 ppm F (partes por millón), indicar la dosis adecuada; en el caso de niñas y niños menores de 3 años, el tamaño de la pasta dental es de un grano de arroz; y, si la niña y el niño es mayor de 3 años, el tamaño de la pasta dental es de una alverjita. Se indica que es recomendable escupir el exceso de pasta dental de la boca y no enjuagarse la boca con agua después del cepillado.
- ✔ Recomendar al padre, madre, tutor y/o cuidador que, para asegurarse que la pasta dental contenga la cantidad de fluoruro adecuado, se debe revisar la etiqueta de la pasta dental y constatar que contenga fluoruro entre 1000 a 1500 ppm F (partes por millón). Si es factible se podría contar con una pasta dental como muestra para la demostración
- ✔ Recomendar al padre, madre, tutor y/o cuidador que el cepillo tenga cerdas suaves y cambiarlo cada 3 meses o cuando se vean las cerdas desgastadas. El cepillo se debe mantener en un lugar ventilado y protegido para evitar su contaminación. Se puede contar con cepillos de muestra.

**En esta sesión se puede utilizar material como hilo dental, cepillo dental y maqueta para la demostración directa y así fortalecer el aprendizaje*

Fuente: Elaboración propia – Dirección de Salud Bucal de la DGIESP - MINSA

ANEXO 3: PREVENCIÓN DE LAS MALOCLUSIONES

En la atención estomatológica de la gestante o madre en periodo de lactancia por parte del cirujano dentista [16,47,48,49,50,62]

- Brindar consejería y orientación a la gestante y a la madre lactante sobre la higiene oral del lactante a partir de la erupción del primer diente, enfatizando la necesidad de la primera visita odontológica antes del primer año de vida.
- Fortalecer la importancia de los dientes deciduos, descartando la creencia que *"los dientes de leche se caen y se pueden perder porque van a salir dientes nuevos",* concientizando a la gestante sobre la importancia de mantener los dientes deciduos sanos.
- Informar sobre las caries de la primera infancia, debido a que la prevención e intervención temprana de la presencia de caries de la primera infancia, evita la pérdida precoz de la pieza dentaria, por lo cual se reduce el riesgo de presentar maloclusiones.
- Durante la atención, fomentar la importancia de lactancia materna exclusiva, por los menos, los 6 primeros meses de vida y recomendando la lactancia prolongada hasta los 24 meses, acompañada de alimentación complementaria para mejorar la nutrición y el crecimiento de la niña y el niño.
- Informar a la madre que la lactancia materna reduce el riesgo de desarrollar maloclusiones; a mayor tiempo de lactancia materna, menor es la probabilidad de presentar maloclusiones, además reduce la severidad las maloclusiones por factores genéticos; y, la "acción de apretar" en la lactancia estimula el desarrollo de las estructuras orofaciales.
- Informar a la madre sobre el cuidado de la salud bucal de la niña y del niño.
- Informar a la madre sobre la presencia de los malos hábitos orales, como el hábito de succión no nutritiva (chupón/tetina).

Acciones del cirujano dentista ante malos hábitos orales [40,55,62]

- Informar al padre, la madre, tutor y/o cuidador lo que significa que la niña y el niño apriete y empuje la mandíbula.
- Según edad del niño y la niña, se le puede indicar que controle su comportamiento durante un periodo de una a 2 semanas, bajo la supervisión del padre, madre, tutor o cuidador.
- Obtener información sobre los hábitos orales, esto incluye interrogar al padre, madre, tutor o cuidador, así como a la niña o el niño, de acuerdo con su edad.
- Se le pide nuevamente al padre, la madre, tutor y/o cuidadores que observe si el niño y la niña rechina los dientes, mantiene los dientes juntos o se aprieta la mandíbula mientras duerme.

Orientación para el cirujano dentista en erupción dentaria[31,53,61]

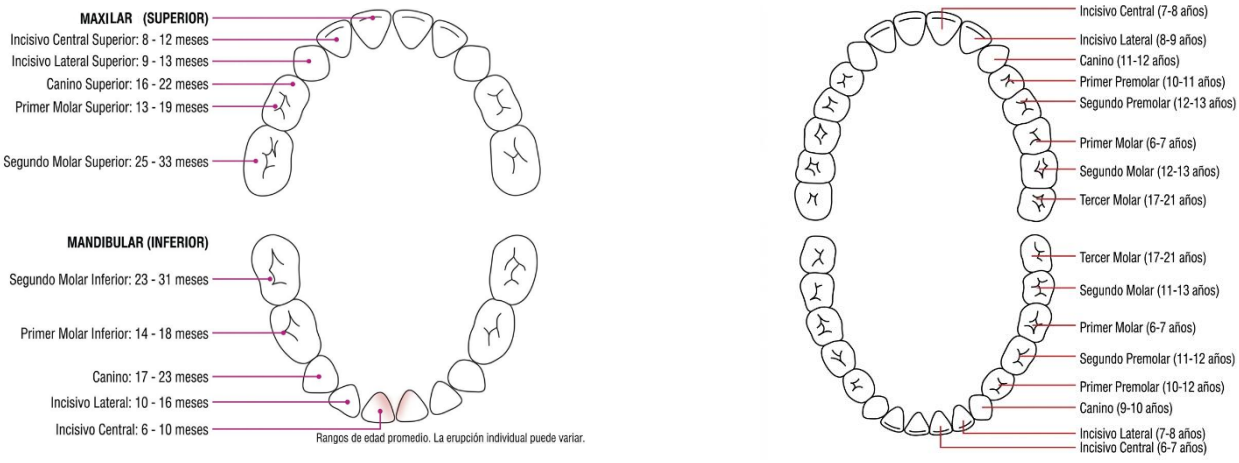
Informar a al padre, madre, tutor y/o cuidador sobre la cronología de la erupción dentaria (retrasada o acelerada) y su implicancia en la presencia de las maloclusiones, mediante imágenes, maquetas y/o videos u otros.[31]

Considerar algunas condiciones que pueden ser un factor de riesgo para la presencia de maloclusiones, como son la erupción ectópica, la ausencia congénita de dientes, dientes supernumerarios, impactación dentaria, anquilosis, diente retenido.[53]

Informar al padre, madre, tutor y/o cuidador sobre:

- La asociación de erupción dental y los problemas sistémicos y nutricionales.
- El espacio entre los dientes anteriores en la dentición temporal es normal; estos espacios ocurren con mayor frecuencia en mesial del canino superior y distal del canino inferior, llamados espacios primates.
- El espacio entre los dientes anteriores puede estar presente en la primera etapa de la erupción de los dientes temporales, aumentando con el crecimiento del alveolo; la falta de espacio en la dentición temporal puede considerarse como un factor de riesgo para la presencia de maloclusiones, ya que podría desarrollar apiñamiento dentario en la erupción de la dentición permanente.
- La erupción tardía de uno o más incisivos permanentes puede conducir a la pérdida de espacio, presencia de apiñamiento dentario, y los dientes adyacentes tienden a desplazarse hacia el espacio necesario para los dientes no erupcionados. Los dientes permanentes erupcionan en grupos con 2 periodos principales de actividad. La primera ocurre entre las edades dentarias de 6 a 8 años, cuando erupcionan los incisivos permanentes y los primeros molares permanentes; y, la segunda, entre los 11 y 12 años, cuando erupcionan los caninos, premolares y segundos molares permanentes.[61]

Imagen Nº 8: Dentición temporal y dentición permanente



Fuente: Imagen de la Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

ANEXO 4: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SALUD Y AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD [65]

El cirujano dentista capacita al personal de la salud y a los agentes comunitarios de salud sobre la importancia de la preservación de la salud bucal y su impacto en la calidad de vida de la niña y el niño. Asimismo, fortalece sus competencias para la prevención y el diagnóstico temprano de las maloclusiones; considerando las repercusiones psicológicas, sociales y en la salud general asociadas a las maloclusiones persistentes no tratadas; a efecto que:

- □ El personal de la salud realice interconsulta y/o referencia al cirujano dentista en los siguientes casos:
  - ✔ Pérdida de continuidad en el labio o paladar (labio o paladar fisurado).
  - ✔ Frenillo lingual corto.
  - ✔ Apiñamientos de dientes (dientes torcidos).
  - ✔ Asimetría facial (Cara torcida).
  - ✔ Dolor al masticar en región de ATM.
  - ✔ Limitación de la apertura bucal.
  - ✔ Malos hábitos orales como la succión no nutritiva (succión digital y uso de chupón).
- □ El personal de la salud y los agentes comunitarios de salud capacitados informan al padre, madre, tutor y/o cuidador que, si observan alguna anormalidad en la erupción de los dientes y las características descritas debe visitar al cirujano dentista; que la visita al cirujano dentista debe realizarse los primeros meses de vida, sobre todo antes de cumplir el primer año de vida; y que, las maloclusiones no tratadas causan problemas funcionales, como problemas en el habla, la masticación y la posterior elección restringida de alimentos, además de causar daño en el aspecto psicológico y social afectando la calidad de vida del niño.
- □ El personal de la salud y los agentes comunitarios de salud capacitados brindan información al padre, madre, tutor o cuidador sobre la importancia de una buena alimentación del niño y de la niña para un adecuado desarrollo craneofacial.

**Puede utilizar material audio visual u otros recursos didácticos para fortalecer el aprendizaje*

Fuente: elaboración propia – Dirección de Salud Bucal – DGIESP – MINSA

ANEXO 5: FICHA DE RIESGO DE MALOCLUSIONES

PARTE I

EVALUACIÓN DEL NIÑO DE 0 a 2 AÑOS 11 MESES y 29 DÍAS	LABIO	Continuo	Discontinuo
	PALADAR	Continuo	Discontinuo
	REBORDE DE ENCIAS	Normal	Alterado
	FRENILLO	Inserción alta	Inserción baja

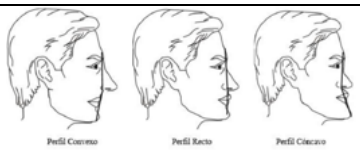
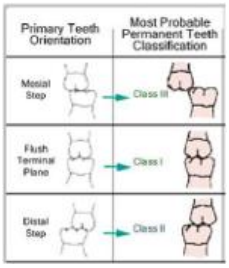
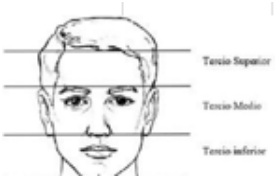
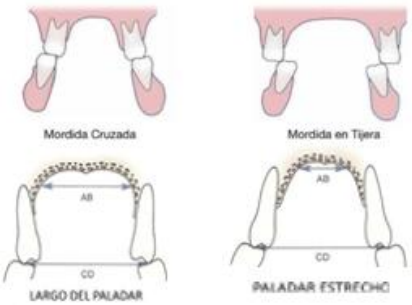
PARTE II

MALOCLUSIONES	PLANO ANTERO POSTERIOR O SAGITAL (perfil)	Perfil	Convexo	Recto	Cóncavo
		Plano terminal (dentición decidua)	Recto	Escalón mesial	Escalón distal
		Relación molar (dentición mixta o permanente)	Clase I	Clase II	Clase III
	PLANO VERTICAL	Tercio inferior	Aumentado	Normal	Disminuido
		Mordida abierta	Si		no
		Mordida profunda (sobrepase vertical mayor al 30%)	Si		no
	PLANO TRANSVERSAL	Forma y profundidad del paladar	Paladar comprimido o estrecho en forma de “V”		Paladar no comprimido o normal en forma de “U”
		Mordida cruzada posterior	Si		no
OTROS HALLAZGOS	Mordida cruzada anterior		Si		no
	Espacios primates		Si		no
	Biprotrusión dentaria		Si		no
	Labios (hasta 3 mm de separación)		competente (normal)		incompetente (incompetencia labial)
	Línea media dentaria coincide con facial		Si		no
	Presenta bruxismo patológico		Si		no
	Malos hábitos orales		si	no	cuáles?
	Pérdida prematura de dientes		si	no	cuáles?

INSTRUCTIVO

Para el llenado de la FRM, primero determine la edad del niño y de la niña:
Niños de 0 a 2 años, 11 meses y 29 días: Complete exclusivamente la Parte I de la ficha
Niños de 3 a 11 años, 11 meses y 29 días: Complete la Parte II.
Evalúe cada condición y marque con una X la casilla respectiva.
La presencia de uno o más hallazgos dentro del área sombreada confirma un diagnóstico presuntivo de maloclusión de la niña y el niño, lo que requiere una interconsulta o referencia al especialista correspondiente.

PARTE I	**Labio:** Identificar la unión de labio superior (continuo) o si presenta una fisura labial (discontinuo). **Paladar:** Identificar la superficie uniforme (continuo) o la presencia de fisura o hendidura (discontinuo). **Reborde de encías:** Identificar características homogéneas en su altura forma y volumen (normal), textura firme o características irregularidades, inflamación, depresiones o prominencias. **Frenillo:** Se considera la presencia de un frenillo lingual corto (inserción baja).

PARTE II	Para la valoración de los hallazgos en las maloclusiones, se consideran los planos del espacio y sus signos. Para la valoración de otros hallazgos, se considera la información contemplada en los recuadros En el caso se evidencie uno o más hallazgos que se encuentren en el recuadro sombreados, se considera como un diagnóstico presuntivo de maloclusiones.	
	MALOCLUSIONES	
	I. Plano sagital	
	Tipo de perfil del paciente puede estar relacionado con la Clase I, II o III esquelética	
	La relación molar entre los primeros molares permanentes en oclusión dentaria nos determinara una Clase I, II o III de Angle o el plano terminal en caso de que solo estén presentes las segundas molares temporales.	
	II. Plano frontal o coronal:	
	La proporción del tercio inferior aumentado (cara larga) se asocia con la mordida abierta esquelética y en el caso este disminuidos se relaciona con una mordida profunda.	
	Se verificará el overbite, para descartar mordidas abiertas y/o profundas.	
	III. Plano transversal u horizontal:	
	Se analiza la relación dentaria-esquelética evaluando el desplazamiento de los dientes en relación con el hueso de sostén o anchura de los maxilares de lado a lado; se puede identificar los ejes se los dientes posteriores hacia lingual o el desplazamiento bucopalatino de los dientes, la bóveda palatina alta y las oclusiones en reloj de arena o en V se consideran entre las principales manifestaciones. donde se manifiestan la mordida cruzada (uni o bilateral) ya se esquelética o dentaria. También se registrará la presencia de desviación de línea media, mordida cruzada uni o bilateral y el eje lingual de los dientes posteriores maxilares dará la presunción de una mordida cruzada posterior dentaria.	

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030 [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022 [citado 25 jun 2026]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484
2. GBD 2021 Oral Disorders Collaborators. Trends in the global, regional, and national burden of oral conditions from 1990 to 2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet [Internet]. 15 de marzo de 2025 [citado el 25 de junio de 2026];405(10482):897-910. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)02811-3
3. Organización Mundial de la Salud. Estrategia y plan de acción mundiales sobre salud bucodental 2023–2030 [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2024 [citado el 25 de Jun de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240090538
4. Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles. Resolución A/66/L1. Nueva York: ONU; 2017.
5. Ministerio de Salud. Modelo de cuidado integral de salud por curso vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI). Documento técnico [Internet]. Lima: Ministerio de Salud; 2020 [citado 25 jun 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1893886-modelo-de-cuidado-integral-de-salud-por-curso-vida-para-la-persona-familia-y-comunidad-mci-documento-tecnico
6. Ministerio de Salud. Decreto Supremo N.° 026-2020-SA: Aprueba la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 "Perú, País Saludable". Diario Oficial El Peruano, (24 de agosto de 2020) [citado 25 de junio de 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1113419-026-2020-sa
7. Ministerio de Salud del Perú. Perfil Epidemiológico de Salud Bucal en Escolares de 3 a 15 años, Perú 2012-2014. Lima: MINSA; 2015.
8. Ireland R. A Dictionary of Dentistry. 1a ed. Oxford: Oxford University Press; 2010 [citado el 25 de jun de 2026]. Disponible en: oup.com
9. American Association of Orthodontists. Decoding Orthodontic Jargon: A Comprehensive Glossary [Internet]. St. Louis (MO): American Association of Orthodontists; 2026 [citado 2026 Jun 25]. Disponible en: https://aaoinfo.org/resources/glossary-of-orthodontic-terms/
10. Ramos RJ. Ortodoncia y sus dispositivos. Sao Paulo: Editora Santos; 2012.
11. Lobbezoo F, Ahlberg J, Raphael KG, Wetselaar P, Glaros AG, Kato T, et al. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018 Nov;45(11):837-844. doi: 10.1111/joor.12663. PMID: 29926505.
12. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (México). Diagnóstico oportuno de las maloclusiones dentales en niños de 4 a 11 años de edad en el primer nivel de atención: Guía de evidencias y recomendaciones [Internet]. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2016 [citado 25 Jun 2026]. Disponible en: https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/
13. Perú. Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Salud Bucal. Manual de registro y codificación de la atención en salud bucal [Internet]. Lima: Ministerio de Salud; 2025 [citado 22 Jun 2026]. Disponible en: https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/7975.pdf
14. Perú. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 537-2017/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N°137-MINSA-2017/DGIESP: Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menores de Cinco Años. Lima: MINSA; 2017
15. Dogramaci E, Rossi G, Dreyer C. Malocclusions in young children. Does breastfeeding really reduce the risk? A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2017;148(8):566-574.e6.
16. Nanda R. Estética y Biomecánica en Ortodoncia 2da. Venezuela: Editorial AMOLCA. 2017. ISBN:978-958-8950-29-7.
17. Bethany R., Anastasios K. oxford handbook clinical dentistry. Seventh edition. UK. Oxford University Press. 2020. ISBN 978– 0– 19– 883217– 1
18. López S, Villalobos J, Ávila L, Casanova J, Vallejos A, Lucas S, et al. Relationship between premature loss of primary teeth with oral hygiene, consumption of soft drinks, dental care and previous caries experience. Sci Rep. 2016;6:21147. doi: 10.1038/srep21147.
19. Bassetti N, La dimensión vertical en Prótesis y Ortognatodoncia. 1era edición. China: Editorial AMOLCA; 2018

20. Bishara Samir E. Textbook of Orthodontics. 1era Edición,University of Iowa (USA): W.B Saunders Company;2001
21. Glick M, Williams DM, Kleinman DV, Vujicic M, Watt RG, Weyant RJ. A new definition for oral health developed by the FDI World Dental Federation: opening the door to a universal measurement. J Am Dent Assoc. 2016;147(12):915-917.
21. Moyers R: Manual de Ortodoncia. Cuarta edición. Ed Médica Panamericana. Buenos Aires 1992.
22. Bishara SE. Ortodoncia. Ed Mc Graw Hill. México D.F. 2003.
23. Zou J, Meng M, Law CS, Rao Y, Zhou X. Common dental diseases in children and malocclusion. Int J Oral Sci. 2018 Mar 13;10(1):7. doi: 10.1038/s41368-018-0012.
24. Loana B, Scrobota I, Todor L, Ioana A, Ligia L, Ligia L. Environmental factors associated with malocclusion in children population from mining areas, Western Romania. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(21):4107. doi: 10.3390/ijerph16214107.
25. Maheshwari K, Singh A, Kaur S, Singla P, Kaur A, Singh G. Determination of Malocclusion and Orthodontic Treatment Need in Patients- A Clinical Study. J Adv Med Dent Scie Res. 2019;7(7):160-162.
26. Sultan M, Halboub E, Salah M, Labib A, El-Saaidi C. Global distribution of malocclusion traits: A systematic review. Dental Press J Orthod. 2018;23(6):40.e1-40.e10.
27. Nishio C. Skeletal Malocclusion and Genetic Expression: An Evidence-Based Review. J Dent Sleep Med. 2016;3(2):57-63.
28. Macedo A, Ferreira J, Augusto L. Factors associated with malocclusion in youth in a municipality of Northeastern Brazil. Rev Bras Epidemiol. 2016;19(3):621-633.
29. Sato S. Occlusion Concept and Occlusion Medicine. En: International Meeting of Occlusion Medicine; 2020; Cartagena, Colombia. Kanagawa Dental University; 2020.
30. Mori B, Quiroz C, Ortiz M. Factores medioambientales asociados a tipos de maloclusión en dentición mixta temprana. Rev Cubana Estomatol. 2022;59(3):e3485.
31. Petcu A, Balan A, Haba D, Martu A, Savin C. Implications of premature loss of primary molars. Int J Med Dent. 2016;6(2):130-4.
32. Doraczynska-Kowalik A, Nelke KH, Pawlak W, Sasiadek MM, Gerber H. Genetic Factors Involved in Mandibular Prognathism. J Craniofac Surg. 2017 Jul;28(5):e422-e431. doi: 10.1097/SCS.0000000000003627.
33. Xue F, Wong RW, Rabie AB. Genes, genetics, and Class III malocclusion. Orthod Craniofac Res. 2010 May;13(2):69-74. doi: 10.1111/j.1601-6343.2010.01485.x.
34. Moreno Uribe LM, Miller SF. Genetics of the dentofacial variation in human malocclusion. Orthod Craniofac Res. 2015;18(Suppl 1):91-99.
35. Singh RNP, Shahi AK, Ramesh V, Sharma S, Kumar S, Chandra S. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment needs among 12-15 years old school children in Patna, Eastern India. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2019;37(3):283-9.
36. Rama K, Lavanyah P, Kamalan M, Yunn S. Management of Bimaxillary Protrusion. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2023;35(1):23-35.
37. Silva M, Manton D. Oral habits--part 1: the dental effects and management of nutritive and non-nutritive sucking. J Dent Child (Chic). 2014;81(3):133-9.
38. Silva M, Manton D. Oral habits--part 2: beyond nutritive and non-nutritive sucking. J Dent Child (Chic). 2014;81(3):140-6.
39. Kragt L, Dhamo B, Wolvins E, Ongkosuwito E. The impact of maloclussions on oral healthrelated quality of life in children - a systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2016;20(8):1881-1894.
40. Dimberg L, Arnrup K, Bondemark L. The impact of malocclusion on the quality of life among children and adolescents: a systematic review of quantitative studies. Eur J Orthod. 2015;37(3):238-47.
41. Zhou Y, Wang Y, Wang X, et al. The impact of orthodontic treatment on the quality of life a systematic review. BMC Oral Health. 2014;14:66. Disponible en: https://doi.org/10.1186/1472-6831-14-66
42. Piassi E, Antunes S, Antunes L. Orthodontic treatment reduces the impact on children and adolescents oral health-related quality of life. Indian J Dent Res. 2016;27(2):213-9.
43. González Campoverde L, Rodríguez Soto A, Soto Cantero L. Factores de riesgo de la maloclusión. Medicentro Electrónica [Internet]. 2020 [citado el 25 de Jun de 2026];24(4):753-766. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432020000400753&lng=es

44. World Health Organization. Breastfeeding [Internet]. Ginebra: WHO; 2015 [citado 25 Jun 2026]. Disponible en: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/nutrition/breastfeeding/en/
45. Abreu L, Paiva S, Pordeus I, Martins C. Breastfeeding, bottle feeding and risk of malocclusion in mixed and permanent dentitions: a systematic review. Braz Oral Res. 2016;30(1):1-21.
46. Hermont A, Martins C, Zina L, Auad S, Paiva S, Pordeus I. Breastfeeding, Bottle Feeding Practices and Malocclusion in the Primary Dentition: A Systematic Review of Cohort Studies. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(3):3133-51.
47. Peres K, Morales A, Giacomeli G, Gomes C. Effect of breastfeeding on malocclusions: a systematic review and metaanalysis. Acta Paediatr. 2015;104(S467):54-61.
48. Perú. Ley N.° 30825. Ley que fortalece la labor de los agentes comunitarios de salud. Diario Oficial El Peruano, 20 de julio de 2018.
49. American Academy of Pediatric Dentistry. Periodicity of Examination, Preventive Dental Services, Anticipatory Guidance/Counseling, and Oral Treatment for Infants, Children, and Adolescents. Pediatr Dent [Internet]. 2018 [citado 25 Jun 2026]; 40(6): 210-221. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29179356/
50. Schmid KM, Kugler R, Nalabothu P, Bosch C, Verna C. The effect of pacifier sucking on orofacial structures: a systematic literature review. Prog Orthod. 2018;19(1):8.
51. Arpalahti I, Hänninen K, Tolvanen M, Varrela J, Rice DP. The effect of early childhood non-nutritive sucking behavior including pacifiers on malocclusion: a randomized controlled trial. Eur J Orthod. 2024 Oct 1;46(5):cjae024. doi: 10.1093/ejo/cjae024. PMID: 39119981; PMCID: PMC11310778
52. Doğramacı EJ, Rossi-Fedele G. Establishing the association between nonnutritive sucking behavior and malocclusions: A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2016 Dec;147(12):926-934.e6. doi: 10.1016/j.adaj.2016.08.018. Epub 2016 Sep 28. PMID: 27692622.
53. Slavicek R. Concepts in Oral Medicine. 1st ed. Austria: Gamm Medizinisch-Wissenchaffliche FortbildungsAG; 2016.
54. Bulanda S, Ilczuk-Czyż D, Nitecka-Buchta A, Nowak Z, Baron S, Postek-Stefańska L. Sleep Bruxism in Children: Etiology, Diagnosis, and Treatment—A Literature Review. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(18):9544. Available from: https://doi.org/10.3390/ijerph18189544
55. Kato T, Yamaguchi T, Okura K, Abe S, Lavigne GJ. Sleep less and bite more: sleep disorders associated with occlusal loads during sleep. J Prosthodont Res. 2013;57(2):69-81. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpor.2013.03.001
56. Palinkas M, De Luca Canto G, Rodrigues LA, Bataglion C, Siéssere S, Semprini M, Regalo SC. 2015.Comparative capabilities of clinical assessment, diagnostic criteria, and polysomnography in detecting sleep bruxism. J Clin Sleep Med. 11(11):1319–1325
57. Oliveira M, Bittencourt S, Destro S, Pereira J. Sleep bruxism and anxiety level in children. Braz Oral Res. 2015;29(1):24.
58. Proffit W. Contemporary Orthodontics, 6ta Edición. Editorial Mosby: USA, 2018
59. Borrie FRP, Bearn DR, Innes NPT, Iheozor-Ejiofor Z. Intervenciones para la interrupción de los hábitos de succión no nutritivos en niños. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(3):CD008694. doi: 10.1002/14651858.CD008694.pub2.
60. Organización Mundial de la Salud. Poner fin a la caries dental en la infancia: manual de aplicación de la OMS [Internet]. Ginebra: OMS; 2021 [citado 25 Jun 2026]. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/poner-fin-caries-dental-infancia-manual-aplicacion-oms
61. Michalowicz BS, Gustafsson A, Thumbigere-Math V, Buhlin K. The effects of periodontal treatment on pregnancy outcomes. J Periodontol. 2013;84(4 Suppl):S195-208. doi: 10.1902/jop.2013.1340014.
62. George A, Veginadu P, Villarosa A, Makino Y, Kim W, Masood M, Martin R, Harada y, Mijares-Majini M. Strategies to integrate oral health into primary care: a systematic review. BMJ Open 2023;13:e070622. doi:10.1136/bmjopen-2022-07062

PERÚ | Ministerio de Salud

Av. Salaverry 801, Jesús María - Lima - Perú
Central: (01) 315 6600
www.gob.pe/minsa